UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
GROSSESSE EXTRA-UTERINE
SANS patient simulé
AVEC geste clinique

Nom du rédacteur : RAKOTOARISOA Loïck

Date de rédaction : 04/12/2023

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 099 – Douleur pelvienne

Domaine de compétence principal (en sélectionner 1 SEUL) : EXAMEN CLINIQUE

Domaine de compétence secondaire (en sélectionner 1 SEUL) : STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Réaliser un examen pelvien et génital avec une attitude adaptée

2- Chercher les éléments de gravité en lien avec le diagnostic évoqué

3- Prescrire de manière raisonnée les explorations complémentaires

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin OUI : Mannequin du centre de simulation, mannequin gynécologique
- Brancard OUI
- 1 table, 1 chaise, 1 spéculum, 1 doigtier, 1 paire de gants, SHA

Instructions à l'étudiant

Vous êtes un interne de garde aux urgences gynécologiques. Vous recevez Mme MARNI, 25 ans, qui se plaint d'une douleur abdominale apparue il a quelques heures.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Réaliser l'examen physique orienté de la patiente.
2. Enoncer les critères de gravité à rechercher.
3. Demander les examens complémentaires pertinents.

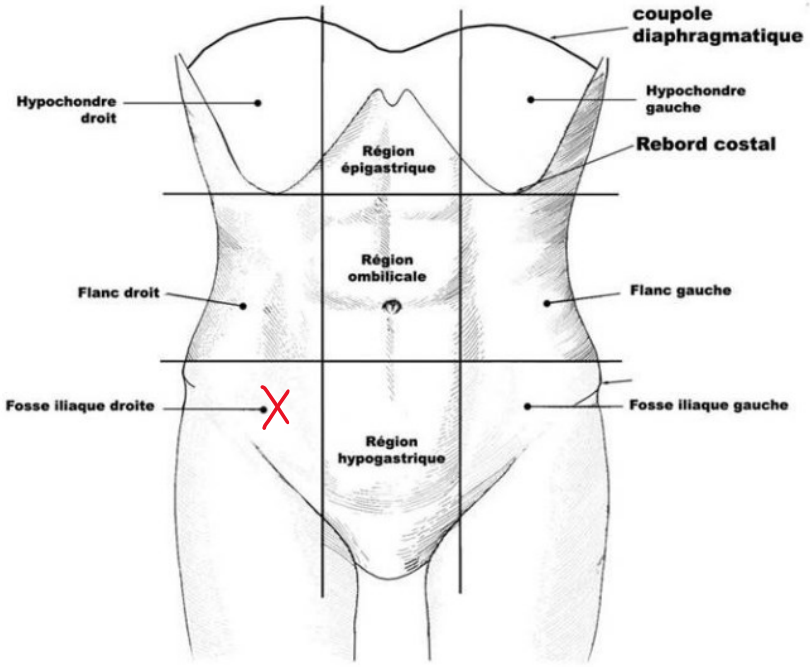
UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1 : EXAMEN CLINIQUE	
Examen abdominal : Palpe les 9 cadrans à la recherche d'une douleur/sensibilité (l'examinateur intervient : « douleur en FID et en hypogastre »)	
Palpe l'abdomen à la recherche d'une défense ou contracture (l'examinateur intervient : « défense en FID »)	
Recherche d'une douleur à l'ébranlement lombaire qui irradie vers les organes génitaux externes (l'examinateur intervient : « pas de douleur déclenchée par l'ébranlement lombaire »)	
Examen gynécologique : Réalise un examen au speculum à la recherche de métrorragies endo utérine (l'examinateur intervient : « légères métrorragies marrons d'origine endo-utérines »)	
Réalise un toucher vaginal à la recherche d'une douleur provoquée à la palpation des culs de sac vaginaux/d'une potentielle masse pelvienne (l'examinateur intervient : « douleur vive au toucher vaginal »)	
Tache 2 : SIGNES DE GRAVITE	
Enonce la recherche d'une pâleur cutanée	X
Enonce la recherche d'un état de choc	X
Enonce la recherche d'une tachycardie	X
Enonce la recherche d'un malaise et/ou d'une perte de connaissance	
Enonce la défense/contracture comme un signe de gravité	
Tache 3 : EXAMENS COMPLEMENTAIRES	
Demande une échographie endovaginale/pelvienne	X
Demande une échographie abdominale	X
Demande une bandelette urinaire AVEC béta-hcG urinaires	
Demande un dosage des béta-hcG plasmatiques/veineux	X
Demande un bilan sanguin avec : NFS, plaquettes, bilan de coagulation (TP, TCA, fibrinogène), groupe sanguin ABO, Rhésus, RAI	
COMPETENCES GENERIQUES	Echelle de 1 à 5
APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE	
APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE	

Schéma des 9 cadrans à palper par l'étudiant lors de la palpation abdominale (douleur et défense en fosse iliaque droite représentée par X) :



UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1 : EXAMEN CLINIQUE	
Examen abdominal : Palpe les 9 cadrans à la recherche d'une douleur/sensibilité (l'examinateur intervient : « douleur en FID et en hypogastre »)	5
Palpe l'abdomen à la recherche d'une défense ou contracture (l'examinateur intervient : « défense en FID »)	3
Recherche d'une douleur à l'ébranlement lombaire qui irradie vers les organes génitaux externes (l'examinateur intervient : « pas de douleur déclenchée par l'ébranlement lombaire »)	1
Examen gynécologique : Réalise un examen au speculum à la recherche de métrorragies endo utérine (l'examinateur intervient : « légères métrorragies marrons d'origine endo-utérines »)	2
Réalise un toucher vaginal à la recherche d'une douleur provoquée à la palpation des culs de sac vaginaux/d'une potentielle masse pelvienne (l'examinateur intervient : « douleur vive au toucher vaginal »)	3
Total tache 1	/14
Tache 2 : SIGNES DE GRAVITE	
Enonce la recherche d'une pâleur cutanée	2
Enonce la recherche d'un état de choc	4
Enonce la recherche d'une tachycardie	2
Enonce la recherche d'un malaise et/ou d'une perte de connaissance	2
Enonce la défense/contracture comme un signe de gravité	1
Total tache 2	/11
Tache 3 : EXAMENS COMPLEMENTAIRES	
Demande une échographie endovaginale/pelvienne	5
Demande une échographie abdominale	1
Demande une bandelette urinaire AVEC béta-hcG urinaires	2
Demande un dosage des béta-hcG plasmatiques/veineux	5
Demande un bilan sanguin avec : NFS, plaquettes, bilan de coagulation (TP, TCA, fibrinogène), groupe sanguin ABO, Rhésus, RAI	2
Total tache 3	/15
	/40
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE	1 à 5
APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE	1 à 5
Note totale	**/50**